



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : عواطف اسماعيل عبدالله اسماعيل

العنوان : ++++++

الحي / المدينة : مدينه السلام

المحافظة : القاهرة

تاريخ تسجيل الإستمارة : 19-09-2026

رقم البطاقة : 26612103200087 رقم التليفون : 01061896188

العمر (تاريخ الميلاد) : 10-12-1966 المهنة : حاصل علي دبلوم

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل :-التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي : (-----) التوقيع: (-----)

المقرر بما فيه : (-----) التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي العلاج المساعد لوقاية العظام للمرضي الذين يتلقوا علاج هرموني حمض الزيلودرونك [14157]

قسم العلاج :
الاورام

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني : الوظيفة : ----- : التوقيع : د/جوستاف روسي
الاسم : د/ندى حسن : الوظيفة : ----- : التوقيع : د/ندى حسن
الاسم : د/نرمين رمضان : الوظيفة : ----- : التوقيع : د/نرمين رمضان

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة رئيس اللجنة ومدير المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. ----- /د.أ. ----- /د. ----- /د. -----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : -----
خطة العلاج : -----
المستشفى : ----- : قسم : -----
جهة العلاج : ----- : نفقات : -----
ملاحظات : -----

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: عواطف اسماعيل عبدالله اسماعيل National ID: 26612103200087	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Zoledronic acid for bone protection during hormonal therapy
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

عواطف

اسماعيل عبدالله اسماعيل

ب ١٢٩٠ دلكتا ٢

أول السلام - القاهرة

١٩٦٦/١٧/٢٠

٢ ٦٦ ١٢ ١٠ ٣٢ ٠٠٠ ٨٧

JL4702603

DMS
عواطف



٢٠٢٢/٠٧

٢٦٦١٢١٠٣٢٠٠٠٨٧

حاصله على ديوان تجاره

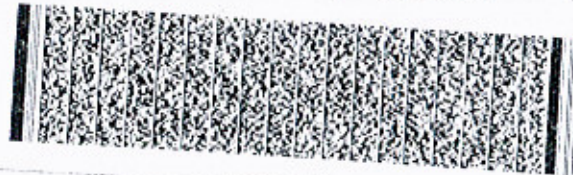
متزوجة

مسلمة

أنثى

محمد على محمد رضوان

البطاقة سارية حتى ٢٠٢٩/٠٧/٢٠





Patient Name	: الأستاذ / عواطف اسماعيل عبدالله	Request No.	: 130&21
Patient No.	: 26612103200087	Request Date	: 17/10/2021
Path No.	: 2456/21	Verification Date	: 03/11/2021
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - مبادره
Age	: 53 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc :			

Pathology Report

Clinical Data:

Left breast cancer, post chemotherapy.

Nature of the specimen:

Right MRM.

Gross Examination:

The specimens received, submitted as:

- 1- Labeled wide local excision; 9x5.5x5 cm, partially covered by skin ellipse; 8.5x4 cm. Sectioning showed an ill-defined grayish white mass; 2.5x2x1 cm.
- 2- Sentinel lymph node: 8 nodules. The largest was 2x1.5 cm.
- 3- Extra-medial margin: fibro-fatty tissue piece; 5x4 cm.
- 4- Axillary dissection; 5x3x2 cm, entangling 13 lymph nodes, Largest; 1.5x1 cm.

• Frozen section: Two fibrofatty tissue piece, medial margin and sentinel lymph nodes. The result was Positive micrometastasis in 2 out of 8 lymph nodes and medial margin with atypical hyperplasia and luminal microcalcification for extended margin.

Microscopic examination:

- Histological type: Invasive duct carcinoma .
- Grade: II .
- Angioinvasion:
- Ductal carcinoma in situ: Focal insitu component; 10% .
- Tumor extent:
 - o Number: 1 mass .
 - o Size: 2x1.5 cm.
- Lymph node involvement: 2 out of 21 lymph nodes showed micrometastasis with extra-capsular extension. .
- Resection Margins: Extra margin showed positive lymphatic tumor emboli .
- Histologic response to therapy: poor response.



Patient Name : الأستاذة / عواطف اسماعيل عبدالله	Request No. : 130821
Patient No. : 26612103200087	Request Date : 17/10/2021
Path No. : 2456/21	Verification Date : 03/11/2021
Sex : Female	Financial Category : مبادره - اورام دار السلام
Age : 53 Y	Department : Out Patient
Referreing Doc :	

Pathology Report

Diagnosis:

Right MRM, Post neoadjuvent chemotherapy

- Invasive duct carcinoma. GII. with insitu component; 10%.
- Extra-medial margin showed positive lymphatic tumor emboli.
- Lymph node status: 2/21. with extracapsular extension.
- TNM: ypT2 ypN1.

Prof. Dr. Aml Hareedy.
Dr. Mona Mohamad



Women's Health Outreach Program

Name: AWATEF ISMAIL ABD ALLAH

Date: 23.09.2021

Contrast Enhanced Full field Digital Mammography

Clinical summary: left breast malignant mass..

Technique

Pre & post contrast Mediolateral oblique and CC views

Targeted High resolution ultrasound

Detailed Findings

Left breast:

- mild back ground parenchymal enhancement.
- **Pre-contrast images:** ill defined asymmetrical area located at the upper outer quadrant.
- **Post-Contrast enhanced images demonstrated:** intense enhancing mass enhancement located at the UOQ corresponding to the aforementioned lesion located **4 cm from the nipple, measure 2.7 x2.4x2.5 cm.**
- No pathological axillary LN by ultrasound.

Conclusion:

-Left breast: (BIRADS 6= Pathology proved malignant). unifocal UOQ pathologically enhancing mass.

Best regards,
Dr Hanaa abo el magd



Patient Name: Awaterf Ismail Abd Allah Ismail	Date : 14/09/2023
Exam : ultrasound BREAST (BOTH SIDE)	Age : 56 Year(s)
Medical ID: 3530/2021	Pat. ID: 20340

left BREAST MAMMOGRAPHY WITH BILATERAL US

Indication:

Patient had right MRM in and left CBS

Technique

- Left-breast MLO and CC views
- Bilateral ultrasound

Report:

- The left breast is heterogeneously dense (ACR C)
- Left breast focal area of parenchymal distortion owing to prior surgical interference, with post-operative scarring and diffuse edema pattern in the form of increased trabeculations and skin thickness.
- Clear left operative bed with no evidence of recurrence
- Normal skin thickness and nipple-areola complex, with average caliber of the retro-areolar ducts.
- Nonspecific left axillary LN, with preserved fatty hila and uniform cortical thickness.
- Free right MRM operative bed with no evidence of recurrent mass lesions
- Free bilateral infra and supra clavicular regions.

Opinion:

- Left breast focal parenchymal distortion owing to prior surgical interference (CBS) with post-operative sequel, with free operative bed with no evidence of recurrent mass lesions (BIRADS 2)
- Right MRM with free operative bed with no evidence of recurrent mass lesions .

Yours truly

Signature Dr. Engy Abdallah

14/09/2023 1:23 PM